

Medicina 2026.2

Planos de ENSINO

1º Período - 2º/2026

UNIEURO
CENTRO UNIVERSITÁRIO

Instituição	Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO		
Curso	Graduação em Medicina		
Período	1º Período		
Unidade Curricular	Habilidades e Atitudes I		
Carga Horária Total	80 horas	CH Extensão	-
Ano Letivo	2026.2		

1. EMENTA

Introdução à semiologia médica e à semiotécnica, com foco na aquisição progressiva de habilidades para a realização da anamnese, domínio da linguagem técnico-científica da Medicina e desenvolvimento de atitudes fundamentais para a relação médico-paciente. Ênfase nas etapas iniciais do exame físico, incluindo ectoscopia, exame físico da cabeça e pescoço, e aferição dos sinais vitais.

2. OBJETIVO GERAL

Desenvolver competências e habilidades fundamentais de anamnese, semiotécnica e raciocínio clínico inicial no estudante de Medicina, estimulando postura ética, empática, humanizada e tecnicamente precisa na relação médico-paciente, com suporte e conscientização sobre o uso seguro de tecnologias e saúde digital.

3. COMPETÊNCIAS

3.1 Conhecimentos

- Compreender os princípios teóricos da anamnese, semiologia e semiotécnica aplicados à relação médico-paciente e ao exame físico inicial.
- Dominar a terminologia técnico-científica médica necessária para a descrição precisa de sinais, sintomas e achados clínicos.
- Reconhecer os padrões fisiológicos e as alterações nos sinais vitais, dados antropométricos, ectoscopia e região de cabeça e pescoço.
- Entender o papel da saúde digital, da IA generativa responsável e dos registros eletrônicos de saúde na rotina clínica e na segurança do paciente.

3.2 Habilidades

- Realizar a coleta estruturada da história clínica (anamnese completa, HDA, interrogatório sistemático, antecedentes e hábitos de vida).
- Executar com destreza técnica as manobras de exame físico básico, aferição de sinais vitais, ectoscopia e inspeção/palpação de cabeça e pescoço.

- Registrar dados clínicos de forma organizada, ética e precisa em prontuários físicos e eletrônicos.
- Integrar criticamente dados semiológicos ao raciocínio diagnóstico inicial e ao apoio de ferramentas digitais clínicas.

3.3 Atitudes

- Demonstrar empatia, ética, postura profissional humanizada e respeito à dignidade, diversidade e singularidade do paciente durante a abordagem clínica.
- Atuar de forma colaborativa e respeitosa em equipe interprofissional, reconhecendo os limites da própria atuação e a importância do trabalho compartilhado.
- Adotar práticas sistemáticas de segurança do paciente, biossegurança e prevenção de eventos adversos em todos os cenários de aprendizagem.
- Respeitar a autonomia, a privacidade, a diversidade e os valores culturais dos pacientes e de seus familiares.
- Assumir responsabilidade pelo próprio processo de aprendizagem, buscando autoavaliação, feedback contínuo e desenvolvimento profissional permanente.
- Zelar pelo uso ético, crítico e responsável das tecnologias digitais e de inteligência artificial na prática clínica, resguardando a confidencialidade e a segurança das informações do paciente.

4. CONTEÚDOS

Unidade I - Relação Médico-Paciente e Anamnese

Comunicação clínica, empatia e humanidades na prática médica.

História da Doença Atual (HDA) e caracterização sintomática (ex: dor, febre, dispneia, diarreia, vômitos).

Interrogatório sintomático / revisão de sistemas.

Antecedentes fisiológicos, patológicos, familiares, hábitos de vida e contexto sociocultural.

Unidade II - Semiotécnica Geral, Ectoscopia e Sinais Vitais

Técnicas Gerais: Inspeção, palpação, percussão e ausculta.

Sinais Vitais: Aferição e interpretação de PA, FR, FC/pulso e temperatura.

Ectoscopia: Nível de consciência (sono-vigília, orientação), estado geral, biotipo, postura, fácies, coloração de mucosas, hidratação e estado nutricional.

Lesões elementares da pele.

Unidade III - Exame Físico Segmentar Inicial

Exame físico dirigido de Cabeça, Face e Pescoço (inspeção, palpação de linfonodos e tireoide).

Unidade IV — Segurança do Paciente

Princípios de segurança do paciente aplicados ao exame físico (higienização das mãos, identificação do paciente, biossegurança).

Unidade V - Saúde Digital, Inteligência Artificial e Segurança da Informação

Uso crítico e ético de prontuário eletrônico, telessaúde e sistemas de informação em saúde; ferramentas de inteligência artificial aplicadas à semiologia, ao raciocínio clínico inicial e ao apoio à decisão;

segurança da informação e proteção de dados do paciente; limites, vieses e riscos da automação na prática clínica.

5. METODOLOGIAS

O desenvolvimento da unidade curricular integra metodologias ativas e supervisão direta da prática, articulando os domínios cognitivo, psicomotor e atitudinal, conforme as seguintes estratégias:

- **Discussão baseada em casos de casos e de anamneses em grupo** - Análise crítica de histórias clínicas reais e simuladas em pequenos grupos para estímulo do raciocínio semiológico.
- **Simulações práticas em pares e trios** - Atividades práticas role-playing em laboratório para consolidação do treino de anamnese e habilidades interpessoais.
- **Orientações expositivas dialogadas** - Apresentação e contextualização teórico-prática dos conteúdos essenciais da semiologia e humanidades, com participação ativa dos estudantes.
- **Estações com modelos anatômicos e de simulação** - Treinamento repetitivo e seguro de procedimentos propedêuticos e aferição de sinais vitais, sob supervisão docente, com *feedback* formativo contínuo.
- **Feedback estruturado (pares, professores e autoavaliação)** - Processo contínuo de debriefing e autoavaliação guiada para aperfeiçoamento progressivo de atitudes e habilidades técnicas.
- **Aprendizagem baseada em tecnologias digitais** - uso orientado de prontuário eletrônico, plataformas de telessaúde e ferramentas de inteligência artificial como apoio à semiologia e à prática clínica, com discussão crítica de seus limites e implicações éticas.
- **Trabalho em pequenos grupos e simulação interprofissional** - atividades colaborativas voltadas ao desenvolvimento de comunicação, liderança, profissionalismo e segurança do paciente.

6. AVALIAÇÃO

6.1 Instrumentos e Procedimentos Avaliativos

Avaliação N1 e N2

Instrumento	Descrição	Quando	Peso	Observação
OSCE (Objective Structured Clinical Examination)	**Avaliação Somativa (AS).** Avaliação prática em estações simuladas	N1: 07 OUT N2: 17 NOV e 24 NOV	8,0	Checklist estruturado e critérios objetivos de desempenho
Avaliação atitudinal e de profissionalismo	**Avaliação Formativa (AF).** Registro do desempenho progressivo do estudante nas práticas de laboratório. Observação direta de comunicação, trabalho em equipe, ética, segurança do paciente e humanização do cuidado	Ao longo de todo o bimestre	2,0	Caráter formativo. Avaliação quantitativa

Instrumento	Descrição	Quando	Peso	Observação
Autoavaliação e avaliação por pares	Reflexão estruturada sobre o próprio desempenho e o de colegas em atividades simuladas e supervisionadas	Ao final do bimestre	-	Caráter formativo. Avaliação qualitativa

- O estudante que não atingir a frequência mínima de 70% nas atividades práticas de laboratório da Unidade Curricular no bimestre receberá nota ZERO na Avaliação Formativa (AF).

- ARA: 1º DEZ 2026

6.2 Critérios de Aprovação

Conforme Resolução do Conselho Superior (Resolução Consu nº 23, de 29/06/2026):

Será considerado aprovado o estudante que obtiver frequência mínima de 75% nas atividades da Unidade Curricular e Média Parcial (MP) igual ou superior a 6,0, calculada pela média aritmética simples das notas de N1 e N2, não havendo arredondamento.

O estudante com MP inferior a 6,0 poderá realizar a Avaliação de Recuperação das Aprendizagens (ARA), sendo aprovado se alcançar Média Final (MF) igual ou superior a 6,0, calculada pela fórmula MF = (MP + ARA) ÷ 2, aplicando-se o arredondamento institucional apenas à Média Final, com aprovação a partir de 5,75, registrada como 6,0.

O estudante que deixar de realizar a N1 ou N2 poderá requerer prova de segunda chamada, EXCETO para provas práticas e OSCE, mediante solicitação no prazo previsto no Calendário Acadêmico, apresentação de documentação comprobatória e pagamento da taxa administrativa, nos casos previstos pela Instituição (doença, falecimento de familiar, convocação judicial ou militar e participação em eventos oficiais autorizados).

A nota obtida na segunda chamada substituirá integralmente a nota da avaliação correspondente, não sendo admitida para melhoria de nota em N1 ou N2.

Não há 2ª Chamada para a Avaliação de Recuperação das Aprendizagens (ARA).

7. CRONOGRAMA

O cronograma detalhado contendo a distribuição das aulas, práticas em laboratório, datas de avaliações e momentos de feedback será disponibilizado aos estudantes no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

8. OUTRAS INFORMAÇÕES

Poderão ocorrer ajustes no cronograma apresentado, a partir da constatação de necessidades específicas, visando manter a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Esses eventuais ajustes, entretanto, não resultarão em alteração do conteúdo programático proposto.

Não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos (como celular, tablet e laptop), nem fotografar ou filmar durante as atividades teóricas e/ou práticas, de forma a resguardar o direito de imagem, assegurado pela Constituição Federal de 1988 e pelo Código Civil de 2002.

É terminantemente proibido portar, manter sob guarda ou utilizar quaisquer dispositivos eletroeletrônicos durante todo o período de realização das avaliações, incluindo telefones celulares, relógios inteligentes, fones de ouvido, tablets e equipamentos similares. A proibição aplica-se, sem exceção, a todos os ambientes vinculados ao processo avaliativo: salas de prova, laboratórios, áreas de espera pré-avaliação, banheiros e áreas de circulação durante o período de prova. O descumprimento, independentemente do uso efetivo do dispositivo, é passível de enquadramento como irregularidade (Circular nº 004/2026).

Será atribuída nota zero ao estudante que usar de meios ilícitos ou não autorizados pelo docente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis por ato de improbidade (Art. 7º).

Identificada irregularidade que comprometa a lisura do processo avaliativo, aplicam-se as medidas previstas na Circular nº 004/2026, incluindo a anulação integral da avaliação para todos os estudantes da turma envolvida, a instauração de procedimento administrativo disciplinar e as sanções do Regimento Interno.

As avaliações poderão ser acompanhadas por mecanismos de monitoramento institucional.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

9.1 Básicas

1. BICKLEY, Lynn S.; SZILAGYI, Peter G.; HOFFMAN, Richard M. **Bates - Propedêutica Médica Essencial: Avaliação Clínica, Anamnese, Exame Físico**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527738446/.

2. PORTO, Celmo Celeno. **Exame Clínico**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527731034/.

3. ROCCO, José R. **Semiologia Médica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595159136/.

9.2 Complementares

1. HINRICHSEN, Sylvia L. **Biossegurança e Controle de Infecções - Risco Sanitário Hospitalar**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2023.

2. MARTINS, Mílton de A. et al. **Semiologia clínica**. Santana de Parnaíba: Editora Manole, 2021.

3. MATTOS, Waldo. **Semiologia do Adulto - Diagnóstico Clínico Baseado em Evidências**. Rio de Janeiro: MedBook Editora, 2017.

4. PORTO, Celmo Celeno. **Semiologia Médica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

5. SOUSA, Lucila Medeiros Minichello de. **Suporte Básico a Vida**. São Paulo: SRV Editora LTDA, 2014. E-book.